Identifikace pacienta
Jméno pacienta: **Libor**
Příjmení pacienta: **Opletal**
Rodné číslo:
Pojišťovna pacienta:

Zdravotní stav a diagnózy
Anamnéza: **53-letý muž nedávno propuštěn z neu odd. po infuzní analgetizaci pro silné lumbalgie přihcází opět por zhoršení stavu. Bolest se opět postupně zhoršovala, teď těžká porucha statodynamiky, střídavě iritace S1 bilat. K vytlačení moči / stolice musí více tlačit, ale přímo sfinkterové obtíže neguje.**

Zobrazovací vyšetření: **MR Th páteře: Sagitální T2W TSE a T1W TSE, STIR T2 spc řezy v rozsahu C4 - L2. Axiální řezy v rozsahu Th8-Th12, nativ + k.l, podáno 7,5 ml Gadovistu i.v. Spinální mícha s cystickými okrsky od Th4-Th 12, mícha je rozšířená, s maximem v oblasti konu, kde vel. 15x17 mm, v oblasti konu také jemné sytící se okrsky - zde drobný ependymom v terénu výrazné syringomyelie nevyloučím. V sagitálních řezech je hrudní kyfosa oploštělá. Výška obratlových těl je v normě, v.s. drobný hemangiom v obrat. těle th8 pr. 5 mm, v.s. sklerotický okrsek horní zadní hrany Th9 vel. 5x9 mm, Schmorlovy uzly horních krycích ploten Th9, Th11, Th12, jinak signál spongiosy je normální. Meziobratlové prostory jsou snížené ve vrcholu kyfozy, nižší signál disků ve vrcholu kyfosy v rámci počínající degenerace. Ventrolaterální spondylofyty. Incip. spondylarthrotické změny. V segm. Th3/Th4 je diskrétní protruze plotny s akcentací paramediálně vlevo, v segm. Th7/Th8 je diskrétní hernie plotny do 3 mm paramediálně vpravo, s impresí durálního vaku. Páteřní kanál je v zobrazeném rozsahu přiměřené šíře 14-15 mm. Foramina jsou oboustranně volná. Ré: Spinální mícha s cystickými okrsky od Th4-Th12 s maximem v oblasti konu. Mícha je rozšířená, s maximem v oblasti konu, kde mícha vel. 15x1 7 mm, v oblasti konu také jemné sytící se okrsky do vel. 4,5x4 mm - zde drobný ependymom v terénu výrazné syringomyelie nevyloučím. Popisující lékař: MR L páteře, nativ: Provedeny sagitální T2W TSE ,STIR, spc, T1 W řezy v rozsahu Th11 - LS Axiální T2W TSE řezy v rozsahu L4-S1 V sagitálních řezech je bederní lordosa oploštělá. Výška obratlových těl je v normě, Schmorlův uzel dolní krycí plotny L4 a horní krycí plotny Th12. Jinak signál spongiosy je normální. MOP L5/S1 je snížený. Ostatní meziobratlové prostory jsou přiměřené šíře. Ploténky mají normální signál v T2W při degeneraci. Ventrolaterální spondylofyty. Incip. spondylarthroza. Zadní ohraničení disků je ostré, zadní podélný vaz není přerušen. Páteřní kanál je primárně v zobrazeném úseku normální šíře. Foramina L3-L5 bilat jsou omezena. Jinak foramina jsou oboustranně volná. V segm. L3/L4 je cirkulární protruze disku do 3 mm, s oploštěním ventrální plochy durálního vaku,, v kontaktu s odstupy kořenů L4 bilat. V segm. L4/L5 je cirkulární protruze plotny vel. 3**

mm, s impresí ventrální plochy durálního vaku a odstupů kořenů L5 bilat, více vlevo. Hypertrofie facet, s impresí odstupů kořenů L5 bilat, více vlevo, PK AP šíře 14 mm. V segm. L5/S1 je plotna bez výraznějšího vyklenutí, v kontaktu s odstupy kořenů S1 bilat. Zobrazená část dist. míchy ve správné výši, okrajově zachyceno cystické rozšíření míchy. Paravertebrální struktury bpn. Ré: okrajově zachyceno cystické rozšíření míchy - doplňuji MR Th páteře + k.l. V segm. L4/L5 je cirkulární protruze plotny, s impresí ventrální plochy durálního vaku a odstupů kořenů L5 bilat, více vlevo. Hypertrofie facet, s impresí odstupů kořenů L5 bilat, více vlevo, PK AP šíře 14 mm.

Aktuální klinicky stav: **pacient je chodící, bez redukce svalové síly na DKK, babinski neg., rr. L2-S2 sym střední, těžší blokáda Th/L přechodu, perianogenitální čití v normě, bez sfinkterových obtíží**